【2枚目】販売判断の表現案

（上段＝レジでの確認事項　／　下段＝状況別対応のポイント）

④ レジでの確認事項　※該当する場合は下段「状況別対応のポイント」を参照

＋【使用者】今回のお薬は、どなた（ご本人様／12歳未満の小児等）が使われますか？

＋ いつから、どの程度の症状ですか？（適正な使用期間の確認、長引く場合は受診勧奨を判断します）

＋ すでに受診・服薬を開始していますか？（重複投与や飲み合わせ確認のため）

①【年齢・氏名】18歳未満ですか？

（※法令上の確認。18歳未満への大容量・複数個は一律販売不可。お客様には「お薬を安全にお使いいただくための確認です」と説明）

②【重複】他店や他のレジで同じお薬（風邪薬、咳止め等）のご購入はありませんか？

（譲り受けも含みます）

以下は、お薬の安全な選択に関わります。

③【体質】アレルギー歴（アスピリン喘息等）や、喘息、不整脈、緑内障、前立腺肥大等の持病・治療中の病気はありますか？

④【併用】現在、病院で処方されたお薬や、他のお薬を飲まれていますか？（SSRI等との重複防止）

⑤【妊婦】妊娠中（週数）、または授乳中ではありませんか？（妊娠後期のNSAIDs禁忌、授乳中のコデイン避止）

＋ このお薬（または同じ成分）を使ったことはありますか？そのとき副作用はありませんでしたか？

＋【大容量・複数個（成人）】

（※18歳以上であれば購入個数の制限はございませんが、ご理由を伺わなければならない厚労省の規則がございます）

免責: 過去に用法用量超過の自己判断服用で重篤な健康被害が生じた事例を踏まえた確認です。意図的な過量服薬は保証・救済制度の対象外です。

④ 状況別対応のポイント

表記：■赤字＝特に重大な注意（禁忌・販売不可など）／▶黒字＝一般的な注意。「禁忌」はOTC添付文書の「してはいけないこと」に相当（医療用で「慎重投与」の成分でも、OTCでは「してはいけないこと」になる場合がある）。

①②年齢・重複　18歳未満/複数個(他店合算)希望

■18歳未満：大容量・複数個は理由不問で一律不可(家族用も例外なし)。

■12歳未満：コデイン系(ジヒドロコデイン含)絶対禁忌⇒他成分の咳止めへ。

▶身分証拒否：年齢確認不能のため販売不可。

※使用期間の目安　「いつから・どの程度の症状か」で長引いているかを判断

▶かぜの症状は通常、数日でピークを越え1週間前後で改善に向かう(×7区分の根拠)。

▶かぜ薬・せき止め・解熱鎮痛薬の添付文書は多くが「5〜6回服用しても改善しなければ中止して相談」。

▶せき：3週間以上続けば遷延性、8週以上は慢性咳嗽(咳嗽・喀痰の診療ガイドライン)⇒受診勧奨。

③体質(アレルギー)　解熱鎮痛薬でアレルギー歴⇒皮膚か呼吸器かを確認

▶皮膚(ピリン疹などの発疹)：ピリン系以外のNSAIDs(ロキソプロフェン等)へ代替可。

■呼吸器(アスピリン喘息)：NSAIDs全般に交差反応で全てNG⇒アセトアミノフェン(AAP)単剤のみ提案。

③体質(喘息・不整脈等)　喘息/不整脈/緑内障/前立腺肥大/高血圧・糖尿病

▶抗コリン薬・第一世代抗ヒス：喘息=痰粘稠化、不整脈=頻脈・QT延長。

▶緑内障=眼圧上昇、前立腺肥大=尿閉⇒単一成分薬を推奨。

■プソイドエフェドリン：上記に加え高血圧・心疾患・糖尿病・甲状腺機能亢進も対象。

※抗ヒスタミン薬の使い分け　喘息の既往がある方への風邪薬・鼻炎薬の相談

▶第一世代(市販の風邪薬・せき止め等)：原則避ける⇒気道を乾燥させ痰をドロドロにし「痰の嵌頓」を招く危険性(クロルフェニラミンマレイン酸塩等)。

▶第二世代(病院のアレルギー薬・一部の市販鼻炎薬)：比較的安全⇒気道を乾燥させる副作用がほとんどない(アレグラ/フェキソフェナジン、クラリチン/ロラタジン等)。

▶喘息タイプで判断：アレルギー性(花粉・ダニ由来、鼻炎を合併しやすい)は喘息が落ち着いていれば医師処方あり/非アレルギー性(冷気・感染由来)は抗ヒスタミンのメリットがなくデメリットのみのため不要。

※運転　運転前後の服用を心配されたら(半減期の長い成分ほど翌日に持ち越しやすい)

成分(世代)	半減期	⇒回避目安
クロルフェニラミン(1)	12〜24h	翌日まで
プロメタジン(1)	10〜14h	12〜24h
ブロモバレリル尿素	約15h	翌日まで
ブチルスコポラミン(抗コ)	約1.5h	5〜6h控
dl-メチルエフェドリン	約5〜6h	8〜12h
デキストロメトルファン	約3.5h	6〜8h

■当日は運転を避ける成分

成分(世代)	半減期	⇒回避目安
ジフェンヒドラミン(1)	約9h	当日NG
セチリジン(2)	7〜10h	当日NG
ベポタスチン(2)	約2.4h	当日禁止
アゼラスチン(2)	約24h	当日禁止

授乳婦指導(成分別の目安／添付文書の規定ではなく実務上の目安)：

● AAP/イブプロフェン/無水カフェイン(通常量)⇒通常授乳可

● クロルフェニラミン(長期)/プロメタジン/ブロモバレリル尿素⇒搾乳破棄(半減期×3-4h)

● DXM/ジフェンヒドラミン(短期)⇒服薬後2-4h回避

■ コデイン/ジヒドロコデイン(乳児モルヒネ代謝リスク)⇒代替薬へ変更

④併用　SSRI服用中/他剤併用

▶最重要：DXM(デキストロメトルファン)とSSRI等の併用はセロトニン症候群のおそれ(頻度はまれだが重篤化しうる)⇒服用中なら医師・薬剤師へ相談。

▶グレープフルーツジュース(GFJ)でDXM血中濃度↑。マクロライド系/アゾール系はQT延長・心室頻拍に注意。

⑤妊婦・授乳　妊娠中/授乳中と判明

▶妊娠後期のコデイン系は避ける⇒新生児呼吸抑制。DXM単剤(メジコン等)が候補だが、指定成分なので購入制限は同じ。妊婦への可否は添付文書で確認。

■授乳中の抗コリン薬：ロートエキス配合薬は添付文書上「授乳回避」(母乳分泌↓・乳児頻脈のおそれ)。ブチルスコポラミン(ブスコパン等)は添付文書に授乳中断の指示なし⇒成分名で要確認。

■コンタック鼻炎Z(セチリジン)は妊婦投与禁忌。第1世代クロルフェニラミンは比較的安全。

【参考】強心薬(センソ含有)　救心・六神丸等の購入/併用歴の確認

■併用禁忌：センソ含有薬(救心・六神丸等)と医療用強心薬(ジゴキシン等ジギタリス製剤)は併用禁忌⇒不整脈・中毒のおそれ。

▶妊婦は特に注意：センソ・ブシ(附子)は妊娠中の使用に注意を要する成分⇒購入前に必ず確認。

※成分の落とし穴・過量服薬　長期連用・依存・過量服薬の疑い

▶ウレイド系(ブロモバレリル尿素等)：長期乱用⇒臭素蓄積で歩行困難・幻覚(高齢者はせん妄も)。

▶MOH：複合鎮痛薬を月10日超×3ヶ月超服用⇒薬剤乱用頭痛に進展。

■過量服薬：初日=急性心毒性、3日目以降=劇症肝不全(AAP)。AAPは無症状のまま進行。

※外用薬・アンナカ　外用薬/無水カフェインの質問

▶対象外：軟膏・クリーム・目薬等の外用剤(成分含有でも規制対象外)。

▶対象外：トローチ・舌下錠などの口腔用錠剤、含嗽剤、口腔用スプレー(通知で外用剤と明記)。医薬品ドロップは内服扱いで成分次第(4枚目)。

▶対象外：アンナカ(無水カフェイン)。お茶等にも含有、一律規制が非現実的。

※現場で遭遇しやすい主要な注意点の抜粋。全てを網羅するものではありません。

準拠: 厚生労働省 局長通知「指定濫用防止医薬品の指定について」/JSMI「指定濫用防止医薬品の販売制度について」/兵庫県 薬務課 制度改正資料